EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 80140
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-06 08:30:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EMILIO ROMERO ARAVENA			RUN	: 8.471.480-1
F.Nac	: 14-10-1952	Edad	: 71 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 13-02-2024	Fecha Egreso	: 2024-03-06 08:30:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N04-SINDROME NEFROTICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Síndrome Nefrótico impuro
2. Falla Renal Aguda sobre Enfermedad Renal Crónica etapa G5A3
3. Hiperkalemia severa en corrección
4. Anemia severa normocítica y normocrómica
5. Neumonía Adquirida en la Comunidad, resuelta
6. Infección del Tracto Urinario por E. coli tratada
7. Antec: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo IR, Epilepsia, Discapacidad Intelectual severa, Meningioma, Hernia Hiatal, Ectropion bilateral
Dependencia moderada-severa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N04-SINDROME NEFROTICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 71 años con antecedentes de HTA, DM 2IR, epilepsia, discapacidad intelectual, meningioma, ectropión bilateral, dependiente. Es llevado por familiar al servicio de urgencias del Hospital de San Carlos el 22/01/2024 por cuadro de compromiso del estado general, decaimiento y dolor lumbar. Al ingreso se evidencia hipertenso con cifras de hasta 160/70; normotenso, afebril, sin apremio ventilatorio, bien perfundido, sin sangrados evidentes. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca Creatinina de 7.5; hiperkalemia de hasta 6.7 y anemia severa con Hb 6.7, orina completa evidencia hematuria. Por lo que se inician medidas hipokalemiantes: gluconato de calcio, salbutamol e insulina, se inicia hidratación parenteral, se instala sonda Foley y se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos decidiéndose la hospitalización del paciente.

Paciente corrige parcialmente hiperkalemia, sin criterios de urgencia dialítica. En servicio de

medicina persiste con creatinina elevada e hiperkalemia que corrige parcialmente. Se solicita ecografía renal que no evidencia patología aguda; con adecuada diferenciación corticomedular (01/02/24) y PieloTC que resulta negativo para urolitiasis. Presenta clínica respiratoria, se solicita RxTx que impresiona condensación secundaria a aspiración por lo que es tratado con ciprofloxacino, de igual forma UC positivo para E. coli, completado el tratamiento ATB con ceftriaxona. Ante persistencia de falla renal se solicita proteinuria de 24h con valor 9.3 g/d; sumado a hematuria microscópica, hipoalbuminemia, edema periférico leve, hipertensión sistólica; impresiona paciente cursando síndrome nefrótico impuro. Se inicia búsqueda etiológica: VHB NR, VHC NR, C4 disminuido, C3 normal, ASO negativo. Paciente persiste con lesión renal aguda e hiperkalemia que ya no responde a medidas antihiperkalemiantes por lo que se presenta en HHM para traslado e inicio de diálisis.
evaluado por Nefrología el 08/02/2024, sin necesidad de TRR de urgencias, sin indicación de ingreso a HD crónica en contexto clínica (se conversó con hermana Marta Romero).
Paciente en regular estado general, en lo neurologico GCS 14 ptos (4/4/6) se comunica con monosilabos, con contension fisica en EESS Afebril, mas controlada la hipertensión con los ajustes de antihipertensivos orales, taquipneico, resto hemodinamicamente estable, sin requerimientos de oxígeno suplementario. No refiere dolor ni molestias según preguntas dirigidas, con SNG y sonda foley in situ y permeables. Diuresis (+) I Deposiciones (+)
Examen fisico: piel y mucosas moderadamente deshidratadas, llene capilar <3 segundos, yugulares planas, sin adenopatías palpables. Cardiopulmonar: RR2T NAS. Tórax simetrico, hipoexpansible, sin UMA, MP (+) con crépitos basales izquierdo
Abdomen: blando, depresible, indoloro, RHA (+), no palpo masas ni megalias, sin signos de irritación peritoneal .Extremidades inferiores: móviles, pulsos presentes y simétricos, sin edema ni signos de TVP. Upp en región sacra. Miembros. MMSS edema bilateral +, equimosis multiples en ambos brazos pequeñas, sin. MMII: sin signos de TVP. Pulsos presentes. Edema distal periférico leve. .Neurológico: GCS 14 puntos (O4-V4-M6), desorientado en tiempo y espacio, sin focalidad,
En su estado basal en condiciones de alta medica.

PLAN DE MANEJO:

Hospitalización Domiciliaria
Kinesiterapia Respiratoria Y Motora.
Tratamiento Hipertensivo, Mantener Monitoreo Y Ajustar Según Evaluación.
Manejo por APS Posterior alta Hodom
TTO Crónico

INDICACIONES AL ALTA

1. prevención UPP
2. Régimen papilla por SNG
3. Lagrimas artificiales 2 gotas en cada ojo c/4 hrs
4. Cloranfenicol unguento una aplicacion nocturna en cada ojo
5. Resin Calcio Sobre 30 Gr Sobre Unidad 1 Sobre Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
6. Bicarbonato De Sodio Capsula 1 Gramo 2 Capsula Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
7. Acido Folico Comprimido 5 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
8. Fierro + Vitamina (Ferranim O Confer) Capsula Miligramos 1 Capsula Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
9. Hidralazina Comprimido 50 Miligramos 2 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
10. Isosorbida Dinitrato Comprimido 10 Miligramos 1 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
11. Amlodipino Comprimido 10 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
12. Metildopa Comprimido 250 Miligramos 1 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
13. Cloranfenicol Pomo 3,5 Gramos Aplicar 1 Vez Al Dia Noche
14. Polietilenglicol 3350 X 6 Grs Unidad Unidad 1 Unidad Cada 12 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
15. Omeprazol Frasco 40 Miligramos 1 Frasco Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Endovenosa
16. Calcio Carbonato Comprimido 1125 Milígramos / 175 Milígramos 1 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral

17. Furosemida Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
18. Salbutamol Inhalador 100 Microgramos / Dosis 2puff Cada 8 Horas Administrado Por Via Inhalatoria

EXÁMENES Y RESULTADOS

07/02/24: IST 36%; Ferritina 70
Laboratorio 13/02: Glicemia 121; albumina 3.2, Lactato 0.5, PCR 40.3, creatinina 8.5, Calcio 8.9, Fosforo 6.7, TFG 6.23, Uremia 301, Na 139, K 4.1, Cl 105, Ca corregido 9.5 Leucocitos 9.900, Hb 9.1, Plaquetas 182.000, VHS 72, procalcitonina 0.96 GSA PH 7.33, PCO2 21.8, PO2 105, HCO3 11.7, EB -12.4, Sat02 97%.

Rx tx 14/02: Solo AP infiltrado perihiliar, no impresionan consolidaciones establecidas, sin derrame pleural.
Orina 14/02: bacterias escasas, cilindros hialinos escasos, cristales uratos amorfos escasos, mucus en escasa cantidad. Hematíes >100 por campo, leucocitos 5-10 por campo, aspecto transparente, nitritos negativos. Test rápido covid negativo

15/02:Hb 8.1, Hcto 23.8, Leucocitos 7.500, plaquetas 191.000 Crea 9.4, TFG 5.55, PCR 67.9, BUN 172, Uremia 369; Na 141, K 4, Cl 108; Albumina 2.9, Calcio 9.3, Fosforo 8.5, Ca corregido 10.18. 16/02 Albumina 2.6; crea 9, calcio 9.1, TFG 78.8, BUN 172, Uremia 369, Na 136, K 3.8, Cl 103; ca corregido 10.2

Exámenes de lab 21/02 -> crea 8,7; calcio 8, fosforo 9,1; Na/K/Cl 135/4.4/103; Gb 7; Hb/Hcto 8.2/23.8; plaq 190000; segment 65%; GSV pH 7,32; HCO3 12.6.

Lab 28/02/2024 Cra 8.6, TFG 6.15, PCR 45.9, Uremia 372, Na 140, K 6.0, Cl 104 Leucocitos 6.300, Hb 7.1, plaquetas 165.000, hcto 20.9, VHS 78 14/02 Cultivo expectoración SAMS
14/02 UC: e. faecium
Exámenes de derivación -> ANCA P (+), ANA patron nuclear (+), patron citoplasmatico (-), anticuerpo anti membrana basal glomerular (-), anticuerpo anti receptor fosfolipasa A2 (PLA2R) negativo.

Exámenes 5/3/24 leucocitos : 7,70 mil/ul Recuento Hematies : 2,99 * Mill/ul Hematocrito : 26,2 * o/o Hemoglobina : 9,1 * g/dl V.C.M. : 87,8 fl Plaquetas : 155 mil/ul

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO